Официальная медицина: эндометриоз матки

ЖЕНСКАЯ БЕДА

Эндометриоз (аденомиоз) входит в число одних из самых распространённых женских недугов. Заболевание может развиться в любой период жизни женщины, так что можно сказать, что эта болезнь «не имеет возраста». Различные проявления болезни, ее осложнения могут негативно сказываться как на качестве жизни пациенток, так и на их репродуктивной способности. Поэтому редакция решила пригласить читательниц вестника «ЗОЖ» на консультацию гинеколога по поводу эндометриоза матки к врачу высшей категории Вовк Ирине Леонидовне.

«ЗОЖ»: Раскройте, пожалуйста, сущность этого распространенного заболевания.

И.Л.: Эндометриоз называют одним из самых загадочных гинекологических заболеваний. Тот факт, что без лапароскопа практически невозможно достоверно диагностировать это заболевание, обусловливает ситуацию, при которой мы не можем даже назвать приблизительную распространенность эндометриоза, не говоря уже об истинной природе данного заболевания.

Матку изнутри выстилает слой эпителиальных клеток под названием эндометрий. Под воздействием гормональных сдвигов, воспалений, оперативных вмешательств (зачастую как осложнение после абортов) эндометрий, выстилающий матку, начинает распространятся за ее пределы. Он может прорастать во внутренний,

мышечный слой матки, распространяться в сторону наружных половых органов, в сторону маточных труб, яичников, брюшную полость и даже переноситься кровеносной и лимфатической системой в другие, не смежные с репродуктивной системой органы, например, в легкие. В зависимости от локализации процесса проводится и его классификация - наружный эндометриоз шейки матки, эндометриоз матки (аденомиоз), экстрагенитальный эндометриоз (эндометриоз труб, яичников, брюшины эндометриоз легких и т.д.).

Клинически заболевание проявляется прогрессивно нарастающими болями, возникающими непосредственно перед или во время менструации, обильными кровотечениями во время менструации, пред и пост менструальными выделениями. К сожалению, женщины привыкают терпеть подобные состояния и не сразу обращаются к врачу. А болевой синдром не принимают как приобретенное явление, а просто отмечают, что у них болезненные менструации. Что очень жаль, ведь шлейфом за этим заболеванием тянется развитие бесплодия в репродуктивном периоде, а в постклимактерическом возможно развитие эндометриоидной кисты яичника с последующим развитием онкологического процесса.

В современной гинекологической практике такие заболевания, как эндометриоз и миома матки, занимают лидирующее место среди причин, по которым женщины подвергаются оперативному лечению.

«ЗОЖ»: Скажите, как осуществляется диагностика этого заболевания?

И.Л.: Заболевание имеет яркую клиническую картину, которую я перечислила выше, хотя на начальной стадии заболевания симптомы могут и отсутствовать. УЗИ исследование органов малого таза может с высокой вероятностью подтвердить наличие болезни. Так же рекомендовано проведения кольпоскопии для выявления наружных очагов эндометриоза. Для диагностики трубного зндометриоза, эндометриоза яичникоа, эндометриоза полости матки могут потребоваться и более технологичные виды исследований: гистероскопия, эндоскопичческое исследование с последующим обязательным гистологическим исследованием полученного материала. рентгенография и даже в некоторых случаях может быть показано проведение МРТ.

«ЗОЖ»: А по какой причине вынуждены страдать представительницы прекрасного пола?

И.Л.: Пока еще ученым не удалось установить достоверный «корень зла». Наши наблюдения над пациентами с эндометриозом показали роль половых гормонов в патогенезе заболевания. Высокий уровень эстрогенов у женщин, может быть обусловлен ожирением или введением эстрогенов в составе гормональной заместительной терапии (ЗГТ).

Нами замечено, что эндометриоидные очаги начинают появляться под воздействием различных неблагоприятных факторов, таких как, малоподвижный образ жизни, что приводит к нарушению кровоснабжения, застою крови, снижению мышечного тонуса матки. Свою лепту в развитие эндометриоза вносит и полученная в наследство слабая иммунная система. Добавьте сюда аборты и

прием противозачаточных пилюль, которым «балуются» женщины без участия врачей. Гормональный беспорядок усиливает потребление мяса, перекормленных стимуляторами роста животных и загрязненных «химией» продуктов, воды и воздуха.

Репродуктивная система женщин страдает и от злоупотребления курением, хронических инфекций, болезней сердечно-сосудистой системы, крови, после оперативных вмешательств.

«ЗОЖ»: Как же бороться с этим несчастьем при изобилии провоцирующих факторов?

И.Л..: На ранней стадии, при слабой форме эндометриоза, когда эндометриоидных очагов не много, возможна беременность, и именно она, к счастью, может являть исцеляющим фактором. Во время беременности организм сам вырабатывает необходимый гормональный баланс и способен на длительное время тормозить прогрессирование заболевания. Это лучший и самый любимый гинекологами исход заболевания.

Наиболее часто для медикаментозного лечения эндометриоза в комплексном консервативном лечении назначаем агонисты ГнРГ (**бусерелин-депо**, **золадекс**). Второй (стабилизационный) этап, заключается в назначении КОК, что предотвращает рецидивирование роста эндометриозных очагов после отмены агонистов. Назначение агонистов ГнРГ позволяет использовать его и при гиперплазии эндометрия в сочетании миомой матки, тем самым уводить женщин от радикального хирургического лечения.

Так как разрастание эндометриоидной ткани гормонально зависимо, то препаратами выбора являются препараты, тормозящие выработку организмом женского полового гормона –эстрогена (**дюфастон, визанна** и д.р.). Эти препараты, угнетая выработку эстрогенов в организме, подавляют рост эндометрия. Дюфастон мы обычно назначаем по 1 таблетке 2-3 раза в день с 5-25 день цикла. С помощью гормональных препаратов врач моделирует у женщины полное отсутствие месячных, и очаги эндометриоза атрофируются сами по себе. Но остается вероятность возобновления процесса после прекращения курса приема.

Рожавшим женщинам мы можем рекомендовать постановку внутриматочной спирали Мирена, хорошо зарекомендовавшей себя при лечении данного заболевания.

Иногда целесообразно хирургическое лечение заболевания, которое наиболее эффективно на ранних стадиях заболевания. При трубном эндометриозе, эндометриозе яичников показано эндоскопическое вмешательство с иссечением всех эндометриоидных очагов, устранение спаечного процесса и возвращение нормальной анатомии внутренних половых органов. Для удаления используют и различные виды лазера.

В целом эндометриоз можно рассматривать как системное заболевание с иммунологически обусловленным патогенезом. Поэтому, дополнительно в лечении этого заболевания мы применяем симптоматическую терапию: стимуляторы иммунитета, комплексную витаминотерапию, нестероидные

противовоспалительные препараты (**диклофенак, индометацин**) для снятия болевого синдрома.

Не помешает режим физической активности, йога, плавание, скандинавская ходьба, курортолечение с посещением радоновых термальных ванн, что позволяет скорректировать свойственный эндометриозу симптомо комплекс. На фоне регулярных физических нагрузок уменьшается, а иногда и совсем исчезает болевой синдром, значительно уменьшаются кровотечения. Не исключаем и средства народной медицины.

Широко используемый прежде синтетический гормон **даназол**, ныне «вышел из моды» из-за побочных эффектов, включая повышение давления, нарушение менструального цикла, увеличение веса, набухание и боли в груди, рост волос на лице и на теле, прыщи, выпадение волос.

Тактика лечения заболевания на поздней стадии основывается на применение гормональных препаратов, в некоторых случаях требуется хирургическое вмешательство.

«ЗОЖ»: Я слышала, что диагноз «эндометриоз» вызывает у женщин панику из-за опасения онкологической угрозы перерождения пораженных клеток.

И.Л.: К счастью, риск перерождения эндометриоза в рак очень невысокий. Исключением, только является эндометриоз яичников, с развитием эндометриоидной кисты. Вот такая киста яичников, действительно может со временем озлакачествляться. Поэтому важно проходить регулярные обследования у гинекологов особенно

в пред и постклимактерическом периоде, когда возрастает риск перерождения эндометриоидной кисты в рак яичника.

«ЗОЖ»: Конечно, медицина не стоит на месте, и хирургические методы в гинекологии совершенствуются. Но эндометриоз, как говорится, не вчера был открыт. Очевидно, опыт предков тоже имеет значение в наши дни?

И.Л.: Естественно, что с давних времен знахари применяли целебные травы, сдерживающие кровотечения. Первое, что приходит на ум – это, конечно, крапива. Получасовый настой 1 ст. ложки листьев, залитых стаканом кипятка, пьют по полстакана трижды в день. Можно воспользоваться и аптечным экстрактом крапивы. Для усиления сократительной способности гладкой мускулатуры матки, сужения сосудов и торможения маточных кровотечений эффективен берберин, содержащийся в барбарисе. Гинеколог может прописать 30-40 капель настойки листьев барбариса трижды в день в течение 2-3 недель. Но и домашнего приготовления ослабляющие кровотечение настои пастушьей сумки, хвоща полевого, полыни, заячьей капусты, семян сельдерея подойдут как и всевозможные чаи (из душицы, цветов пижмы, тысячелистника). Очень полезна всевозможная зелень – петрушка, шпинат, листья одуванчика, капуста брокколи, настои ячменя и овсяной соломы.

Издавна использовался при обильных кровотечениях в виде отвара водяной перец (горец перечный), который принимают по столовой ложке 3-4 раза в день. Если же это его экстракт зеленовато-бурого цвета и горьковато-вяжущего вкуса, то достаточно 30-40

капель трижды в день. Он уменьшает проницаемость сосудов, повышает свертываемость крови, тонизирует мускулатуру матки, действует успокаивающе на центральную нервную систему. Содержит танин, яблочную, уксусную, галловую кислоты, эфирное масло, пектин, флавоноиды, витамины К и С.

Очень действенной для восстановления менструального цикла, терапии воспалений репродуктивных органов, купирования и профилактики кровотечений считается «гинекологическая тройчатка» - смесь матки боровой, зимолюбки зонтичной и грушанки круглолистной (дикого ладана). Залив 0,5 л горячей воды по 3 ч. ложки каждого из компонентов, выдерживают заготовку на водяной бане и пьют по 0,5 стакана трижды в день.

Еще один рецепт. Высушенные огуречные плети (50 г) заливают 0,5 л воды, кипятят 5 минут, настаивают 1 час. Пьют по полстакана трижды в день.

Полезен во время менструальных расстройств сок свеклы порциями не более 50 мл 2-3 раза в день. Ценное питье - смесь морковного и свекольного сока (0,5 л ежедневно). Можно еще назвать 10-минутный отвар коры калины (1 ст. ложка на стакан кипятка) 3-4 раза в день по 2 ст. ложки.

Травяные добавки в народной медицине используют во время еды в течение нескольких месяцев, регулярно меняя их состав во избежание привыкания. Проявите любознательность и подберите подходящие рецепты, которые помогут избавиться от эндометриоза и поспособствуют возрождению вашего организма.

Беседу записала **Юлия КИРИЛЛОВА**